Estilo UERJ

Simulado 10 Caderno

Prova inédita no formato da UERJ: quatro alternativas, casos longos e a armadilha da banca em cada questão.

50 questões

17 de outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Instruções

- São 50 questões de Clínica Médica, com quatro alternativas cada (A a D) e uma única correta.
- Tempo sugerido: 2 horas e 30 minutos, sem consulta, de uma vez só.
- Marque as respostas na folha de respostas da última página, e só depois abra a resolução.
- Nas questões de identificar, faça o teste do resto: liste os achados e veja se a hipótese explica todos. Antes de pedir exame ou tratamento, pergunte qual é o degrau mais simples que resolve e o que o paciente já usa.
- Na correção, anote em qual arma da banca você caiu. É isso que vai para o diagnóstico, não o total.

1 Homem de 66 anos, internado há 6 dias por pneumonia necrotizante por Staphylococcus aureus resistente à meticilina, recebe linezolida 600 mg de 12/12 horas desde o 3º dia, após lesão renal com vancomicina. Usa em casa escitalopram 20 mg/dia e tramadol para lombalgia, mantidos na internação. Ontem à noite ficou agitado e recebeu haloperidol 5 mg IV. Hoje está confuso, com T 39,2 °C, FC 124 bpm, PA 168 × 96 mmHg, sudorese profusa, midríase, diarreia, tremor, hiper-reflexia e clônus induzível nos membros inferiores, mais intensos que nos superiores. CK 620 U/L. Hemoculturas recentes negativas. O diagnóstico mais provável é:

A) Sepse por nova infecção hospitalar

B) Síndrome neuroléptica maligna

C) Síndrome serotoninérgica

D) Acidose láctica pela linezolida

---

2 Homem de 74 anos, operado de revascularização miocárdica há 5 anos e de túnel do carpo bilateral há 3 anos, tem edema de membros inferiores, aumento do volume abdominal e cansaço há 8 meses. Exame: PA 112×70 mmHg, FC 88 bpm, ritmo regular, turgência jugular que aumenta na inspiração, descenso y profundo, ruído protodiastólico curto e seco no ápice, ascite, sem sopros. ECG: ritmo sinusal, QRS de voltagem normal e alterações inespecíficas da onda T. Ecocardiograma: paredes de 10 mm, fração de ejeção de 58%, átrios moderadamente aumentados, movimento septal anômalo que se acentua na inspiração, variação respiratória do fluxo mitral de 32%, e' septal de 13 cm/s, maior que o e' lateral de 9 cm/s, e veias hepáticas com reversão diastólica na expiração. NT-proBNP de 260 pg/mL. O diagnóstico mais provável é:

A) Amiloidose cardíaca por transtirretina

B) Cardiomiopatia restritiva idiopática

C) Cardiomiopatia isquêmica com disfunção diastólica

D) Pericardite constritiva

---

3 Homem de 52 anos, etilista pesado, é encontrado sonolento em casa após 3 dias de consumo intenso de cachaça com quase nenhuma ingestão alimentar. Não tem diabetes e não usa medicações. O socorrista mediu glicemia capilar de 34 mg/dL e aplicou glucagon 1 mg por via intramuscular; 20 minutos depois, a glicemia era de 36 mg/dL e o paciente continuava sonolento. Na emergência: FC 108 bpm, PA 104 × 66 mmHg, pupilas isocóricas, sem sinais focais, hálito etílico. Gasometria com acidose metabólica de ânion gap aumentado, lactato 3,1 mmol/L, cetonas séricas positivas. O mecanismo da hipoglicemia e a conduta mais adequada são, respectivamente:

A) Hiperinsulinismo induzido pelo álcool / repetir o glucagon

B) Hiperinsulinismo induzido pelo álcool / tiamina e glicose EV

C) Gliconeogênese bloqueada, sem glicogênio / repetir o glucagon

D) Gliconeogênese bloqueada, sem glicogênio / tiamina e glicose EV

---

4 Homem de 72 anos, com polimialgia reumática há 1 ano, controlada com prednisona 5 mg/dia, VHS 12 mm/h e PCR normal. Há 5 meses seus hemogramas mostram monocitose: hoje, leucócitos 15.400/mm³ com monócitos 2.900/mm³ (19%), neutrófilos 10.200/mm³ com alguns hipogranulares, sem blastos; Hb 11,2 g/dL, VCM 101 fL, plaquetas 108.000/mm³. Baço palpável a 3 cm do rebordo costal. Sem febre, sem perda de peso, sem sintomas respiratórios; radiografia de tórax, ecocardiograma e hemoculturas normais; IGRA negativo. B12 e folato normais. O próximo exame mais adequado é:

A) Repetir hemograma em 3 meses

B) Mielograma e biópsia com citogenética

C) Pesquisa de JAK2 V617F

D) PET-CT de corpo inteiro

---

5 Homem de 36 anos, há 14 meses submetido a transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas por leucemia mieloide aguda, em remissão, tem dispneia progressiva aos esforços há 4 meses, sem febre. Teve doença do enxerto contra o hospedeiro em pele e boca, controlada com ciclosporina. Na infância teve bronquite, sem crises desde os 12 anos. Ausculta pulmonar normal, SpO2 95%. Espirometria: VEF1/CVF 0,58, VEF1 54% do previsto (era 98% antes do transplante), sem resposta ao broncodilatador. TC de tórax em inspiração normal; em expiração, aprisionamento aéreo em mosaico difuso. Lavado broncoalveolar sem infecção. O diagnóstico mais provável é:

A) Asma reativada pela imunossupressão

B) Pneumonia em organização

C) Toxicidade pulmonar da ciclosporina

D) Bronquiolite obliterante

---

6 Mulher de 57 anos, com artrite reumatoide há 12 anos, em uso de metotrexato 20 mg/semana, adalimumabe e prednisona 5 mg/dia, controlada há 1 ano (DAS28 de 2,4), refere há 3 dias dor intensa e edema no joelho direito, com dificuldade para deambular. Nega trauma. Tax 37,4 °C, PA 124 × 76 mmHg, FC 92 bpm. Joelho direito quente, com derrame volumoso e dor à mobilização passiva; punhos, metacarpofalângicas, interfalângicas e joelho esquerdo sem sinovite. Leucócitos 11.800/mm³, PCR 98 mg/L. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Artrocentese diagnóstica antes de qualquer droga

B) Infiltração intra-articular de corticoide

C) Aumentar a prednisona para 20 mg/dia

D) Trocar o adalimumabe por tocilizumabe

---

7 Homem de 54 anos, com pancreatite crônica alcoólica (calcificações pancreáticas difusas), abstinente há 2 anos, com diabetes em insulina, mantém 4 evacuações volumosas, gordurosas e malcheirosas ao dia e perda de 3 kg em 4 meses. Foi orientado a tomar pancreatina em cápsulas de 10.000 U de lipase, uma cápsula no meio de cada uma das três refeições principais, e relata adesão completa. Usa omeprazol 20 mg/dia. Exames: elastase fecal de 35 mcg/g, albumina 3,6 g/dL, vitamina D 14 ng/mL, antitransglutaminase IgA negativo com IgA total normal. A causa mais provável da persistência da esteatorreia é:

A) Inativação das enzimas pelo ácido gástrico

B) Doença celíaca associada

C) Dose de lipase insuficiente por refeição

D) Supercrescimento bacteriano do delgado

---

8 Homem de 72 anos, com DPOC grave e retenção crônica de CO2 (gasometria ambulatorial: pH 7,36, pCO2 62 mmHg, bicarbonato 34 mEq/L), foi intubado há 36 horas por exacerbação com pH 7,18 e pCO2 98 mmHg. Desde então está em volume controlado com frequência de 24 irpm. Não recebeu diurético, não tem sonda gástrica aberta e não vomitou. Hoje apresenta extrassístoles ventriculares frequentes; a gasometria mostra pH 7,59, pCO2 39 mmHg e bicarbonato 36 mEq/L; potássio 3,6 mEq/L, cloro 96 mEq/L. Quanto ao distúrbio e à conduta inicial, respectivamente:

A) Alcalose respiratória aguda / reduzir a ventilação-minuto

B) Alcalose respiratória aguda / acetazolamida

C) Alcalose metabólica pós-hipercápnica / reduzir a ventilação-minuto

D) Alcalose metabólica pós-hipercápnica / acetazolamida

---

9 Homem de 64 anos, diabético há 15 anos (HbA1c 8,9%) e hipertenso, procura o ambulatório por visão dupla há 5 semanas. Conta que a pálpebra esquerda 'cai' mais no fim da tarde e após ler; na última semana, em alguns dias, a queda passou a ser também à direita. Nega cefaleia, dor ocular, disfagia ou fraqueza nos membros. Exame: ptose esquerda que aumenta após 60 segundos de olhar sustentado para cima, ptose leve à direita, limitação variável da adução e da abdução do olho esquerdo, pupilas isocóricas de 3 mm com reflexos normais; força e reflexos normais nos membros. O exame mais adequado a seguir é:

A) Angiotomografia intracraniana

B) Hemoglobina glicada e reavaliação em 8 semanas

C) RM de órbitas com contraste

D) Anticorpo antirreceptor de acetilcolina

---

10 Homem de 45 anos, com aids sem tratamento (CD4 18 células/mm³), tem febre diária, sudorese noturna, diarreia e perda de 12 kg em 2 meses. Exame: emagrecido, linfonodos de 1 cm em cadeias cervicais, fígado a 3 cm e baço a 5 cm do rebordo costal. Hb 7,9 g/dL, fosfatase alcalina 620 U/L (referência até 120 U/L), ALT 54 U/L. Radiografia de tórax normal. Hemocultura em meio para micobactérias, positiva no 12º dia: bacilos álcool-ácido resistentes; teste molecular rápido para M. tuberculosis (Xpert MTB/RIF) na amostra: não detectado. Antígeno urinário de Histoplasma negativo. O agente mais provável é:

A) Histoplasma capsulatum

B) Mycobacterium tuberculosis

C) Bartonella henselae

D) Complexo Mycobacterium avium

---

11 Mulher de 56 anos, com varizes de membros inferiores, tem há 3 dias dor, vermelhidão e cordão endurecido na face medial da coxa esquerda, sem trauma, sem acesso venoso e sem febre. Ultrassonografia: trombose da veia safena magna em extensão de 8 cm, com extremidade proximal a 6 cm da junção safenofemoral; veias profundas sem trombose. Sem câncer, sem trombose prévia, sem uso de hormônios. Plaquetas e função renal normais (TFGe 90 mL/min/1,73 m²), sem sangramento. A conduta mais adequada é:

A) Anticoagulação plena por 3 meses

B) Ligadura da junção safenofemoral

C) Fondaparinux 2,5 mg/dia por 45 dias

D) AINE tópico e compressão apenas

---

12 Mulher de 23 anos procura atendimento por crises de taquicardia regular, de início e fim súbitos, desde a adolescência, revertidas com manobra vagal, e cansaço aos esforços moderados. A mãe tem transtorno bipolar e usou o mesmo estabilizador de humor durante toda a gestação. Exame: discreta cianose labial, SpO2 de 92% em repouso, sem baqueteamento digital; PA 104×68 mmHg; pulso venoso jugular sem onda v proeminente; B1 amplamente desdobrada, com componente tardio intenso; B2 com componente pulmonar normal; sopro holossistólico suave na borda esternal esquerda baixa que aumenta na inspiração. ECG de repouso: ondas P altas e apiculadas em DII, PR de 100 ms e onda delta. Radiografia: área cardíaca aumentada à custa de átrio direito, com trama vascular pulmonar diminuída. A cardiopatia de base mais provável é:

A) Comunicação interatrial com síndrome de Eisenmenger

B) Estenose pulmonar valvar grave

C) Anomalia de Ebstein com via acessória

D) Síndrome de Wolff-Parkinson-White isolada

---

13 Mulher de 24 anos tem hirsutismo progressivo desde a menarca, aos 11 anos, acne e ciclos menstruais irregulares. A mãe conta que surgiram pelos pubianos aos 7 anos. Não há engrossamento da voz nem clitoromegalia. IMC 23 kg/m², sem acantose, PA normal. Exames coletados às 8 horas, na fase folicular: 17-OH-progesterona 520 ng/dL (VR até 200), testosterona total 78 ng/dL (VR até 45), DHEA-S normal, prolactina e TSH normais, beta-hCG negativo. Ultrassonografia pélvica: ovários com 14 folículos cada. O próximo exame a ser solicitado é:

A) Supressão com dexametasona 1 mg

B) Tomografia de adrenais

C) 17-OH-progesterona após ACTH sintético

D) Sequenciamento do gene CYP21A2

---

14 Mulher de 44 anos com asma moderada em uso de budesonida-formoterol e rinossinusite crônica com polipose nasal, operada duas vezes, relata que há 2 anos, cerca de 40 minutos após tomar ibuprofeno para cólica, teve obstrução nasal, rinorreia e crise de broncoespasmo com atendimento de emergência. Desde então evita anti-inflamatórios. Agora tem tendinite do ombro, com dor que não cede ao paracetamol 750 mg. Asma controlada, VEF1 de 82% do previsto. O anti-inflamatório mais seguro para esta paciente é:

A) Celecoxibe

B) Naproxeno

C) Diclofenaco

D) Dipirona

---

15 Homem de 57 anos, com cirrose por hepatite C tratada (Child-Pugh B8), é admitido por hematêmese volumosa. PA 96 × 58 mmHg após 1.000 mL de cristaloide e um concentrado de hemácias (Hb 7,4 g/dL), FC 108 bpm. Recebeu terlipressina, ceftriaxona e eritromicina antes da endoscopia, feita em 8 horas, com o paciente intubado para proteção da via aérea. Endoscopia: varizes esofágicas de fino calibre, sem estigmas, que não se continuam para o estômago; no fundo gástrico, variz isolada de grosso calibre com mamilo de fibrina e coágulo aderido. Doppler recente com veia esplênica pérvia. No mesmo exame, a terapia endoscópica mais adequada é:

A) Escleroterapia da variz com etanolamina

B) Cianoacrilato injetado na variz gástrica

C) Ligadura elástica das varizes esofágicas

D) Ligadura elástica da variz gástrica

---

16 Homem de 64 anos, tabagista de 55 maços-ano, tem tosse e emagrecimento de 4 kg. TC: massa hilar direita de 5 cm, linfonodos paratraqueais aumentados dos dois lados do mediastino e linfonodo supraclavicular direito de 1,8 cm, cuja punção mostrou carcinoma de pequenas células. PET-CT e ressonância de crânio: nenhuma lesão fora do tórax e da fossa supraclavicular direita; não há derrame pleural nem pericárdico. Sódio 128 mEq/L, com euvolemia e osmolalidade urinária alta. ECOG 1, função pulmonar adequada para radioterapia. A classificação da doença e o tratamento mais adequados são, respectivamente:

A) Limitada / lobectomia e quimioterapia adjuvante

B) Limitada / quimiorradioterapia concomitante

C) Extensa / quimioterapia com imunoterapia

D) Extensa / radioterapia paliativa

---

17 Homem de 44 anos, etilista, interrompeu a bebida há 2 dias, depois de uma semana de consumo intenso, por vômitos repetidos e dor abdominal; não se alimenta desde então. Não tem diabetes e não usa medicações. Lúcido, sem queixa visual, PA 104/66 mmHg, FC 112 bpm, fundo de olho normal. Exames: glicose 92 mg/dL, sódio 136 mEq/L, cloro 100 mEq/L, bicarbonato 12 mEq/L, pH 7,27, pCO2 27 mmHg, lactato 2,4 mmol/L, creatinina 1,1 mg/dL, ureia 40 mg/dL, etanol sérico indetectável, osmolalidade medida de 290 mOsm/kg e calculada de 284 mOsm/kg, lipase normal. A fita urinária mostra cetonas apenas em traço; o beta-hidroxibutirato sérico é de 6,2 mmol/L. O diagnóstico mais provável é:

A) Cetoacidose de jejum

B) Cetoacidose alcoólica

C) Acidose lática por deficiência de tiamina

D) Intoxicação por metanol

---

18 Homem de 59 anos, engenheiro, é trazido pela esposa porque em 18 meses 'virou outra pessoa': faz comentários sexuais a desconhecidas, gastou as economias em compras impulsivas, come doces compulsivamente (ganhou 9 kg), perdeu a empatia com os netos e repete rituais de abrir e fechar portas. Recebeu diagnóstico de transtorno bipolar há 1 ano, sem resposta ao lítio. Está orientado, lembra-se de fatos recentes e acerta o trajeto até o consultório; nega tristeza. MoCA 25/30, com perdas em fluência verbal e abstração. Sem sinais motores. RM: atrofia frontal e temporal anterior bilateral, predominante à direita, com hipocampos relativamente preservados. O diagnóstico e o tratamento farmacológico mais adequado para os sintomas comportamentais são, respectivamente:

A) Doença de Alzheimer / donepezila

B) Demência frontotemporal / ISRS

C) Demência frontotemporal / donepezila

D) Doença de Alzheimer / ISRS

---

19 Homem de 26 anos tem há 8 dias três úlceras dolorosas no sulco balanoprepucial, de bordas irregulares e solapadas, fundo purulento e friável, base mole, que sangram ao toque. Há 3 dias surgiu linfonodo inguinal direito de 4 cm, doloroso, com flutuação central e pele eritematosa, sem fistulização. Teve relação sem preservativo com parceira casual há 2 semanas. VDRL e teste treponêmico rápido não reagentes; anti-HIV não reagente; PCR para herpes simples na úlcera negativo. O tratamento antimicrobiano e a conduta quanto às sorologias para sífilis e HIV são, respectivamente:

A) Azitromicina 1 g dose única / não repetir

B) Azitromicina 1 g dose única / repetir em 3 meses

C) Doxiciclina por 21 dias / repetir em 3 meses

D) Penicilina benzatina / não repetir

---

20 Homem de 36 anos, assintomático, cujo pai teve adenocarcinoma de cólon aos 52 anos (sem síndrome hereditária identificada); não há outros casos na família. Quanto ao rastreamento do câncer colorretal, o início e o intervalo da colonoscopia são:

A) Aos 45 anos, a cada 10 anos

B) Aos 40 anos, a cada 5 anos

C) Aos 42 anos, a cada 5 anos

D) Agora, a cada 3 anos

---

21 Homem de 52 anos, em pré-operatório de colecistectomia, tem hepatite C tratada com resposta virológica sustentada há 4 anos, sem cirrose à elastografia (5,8 kPa). Assintomático. O hemograma automatizado mostrou plaquetas de 31.000/mm³, com Hb e leucócitos normais; repetido em novo tubo de tampa roxa, 28.000/mm³. Nunca teve sangramento, inclusive em hernioplastia há 3 anos e em extrações dentárias. Exame físico sem petéquias, equimoses ou esplenomegalia. TP e TTPa normais. Ultrassonografia: fígado e baço normais. Não usa medicamentos. O laudo do esfregaço descreve plaquetas agrupadas nas bordas da lâmina. O diagnóstico mais provável é:

A) Hiperesplenismo por hepatopatia

B) PTI secundária ao vírus C

C) Plaquetopenia por fármaco

D) Pseudoplaquetopenia por EDTA

---

22 Homem de 68 anos, com gota e doença renal crônica (taxa de filtração glomerular estimada de 38 mL/min/1,73 m²), usa alopurinol 200 mg/dia há 2 anos, colchicina 0,5 mg duas vezes ao dia como profilaxia e atorvastatina 40 mg/dia. Há 12 dias iniciou esquema de 14 dias para erradicação do Helicobacter pylori, com omeprazol, amoxicilina e um macrolídeo. Há 5 dias tem diarreia aquosa, vômitos, fraqueza proximal progressiva e parestesias nos pés. Exame: desidratado, força grau 3 proximal, reflexos aquileus abolidos. Exames: leucócitos 2.100/mm³, plaquetas 68.000/mm³, Hb 11,2 g/dL, CK 4.800 U/L, creatinina 2,1 mg/dL (era 1,7), K 4,9 mEq/L. A causa mais provável do quadro é:

A) Miopatia por atorvastatina potencializada

B) Colite por Clostridioides difficile

C) Intoxicação por colchicina

D) DRESS pelo alopurinol

---

23 Mulher de 76 anos é trazida pela filha por palpitações há 3 semanas. Foi operada da tireoide há 22 anos (retirada de um dos lobos por "caroço benigno") e desde então toma "um comprimido em jejum". Há 4 meses, ao queixar-se de cansaço a outro médico, teve todas as receitas refeitas. Perdeu 3 kg e anda mais ansiosa. Exame: FC 118 bpm irregular, PA 138 × 76 mmHg, cicatriz cervical antiga, sem bócio ou nódulo palpável, sem oftalmopatia, tremor fino. ECG: fibrilação atrial. Exames: TSH 0,02 mUI/L (VR 0,4 a 4,0), T4 livre 2,1 ng/dL (VR 0,9 a 1,8), T3 livre no limite superior, tireoglobulina sérica indetectável com anticorpo antitireoglobulina negativo, VHS normal. A causa mais provável da tireotoxicose é:

A) Tireoidite silenciosa

B) Doença de Graves de início tardio

C) Excesso de levotiroxina

D) Bócio multinodular tóxico no lobo remanescente

---

24 Mulher de 38 anos, no 40º dia após parto normal, amamentando, sem fatores de risco cardiovascular, tem dor retroesternal intensa iniciada há 3 horas, após uma discussão familiar. ECG: infradesnivelamento de ST de V2 a V5, sem supradesnivelamento. Troponina elevada. Cateterismo realizado em 4 horas: artéria descendente anterior com estreitamento longo, liso e progressivo do terço médio ao distal, sem placas ateroscleróticas em outros segmentos, com fluxo TIMI 3; artérias coronárias de aspecto tortuoso. Na saída da sala, está sem dor, PA 118×70 mmHg, FC 76 bpm, sem arritmias, fração de ejeção de 55%. Além de betabloqueador, a conduta para a lesão coronariana é:

A) Heparina plena por 7 dias

B) Revascularização cirúrgica

C) Tratamento clínico conservador

D) Angioplastia com stent farmacológico

---

25 Homem de 71 anos, aposentado de um estaleiro naval, tem há 3 meses dispneia e dor torácica contínua à direita, com perda de 6 kg. Radiografia: derrame pleural direito moderado. Duas toracocenteses: exsudato linfocítico, ADA 22 U/L, glicose 70 mg/dL e citologia oncótica negativa nas duas. Teste rápido molecular para tuberculose no líquido: negativo. TC de tórax com contraste: espessamento pleural nodular e circunferencial de 1,5 cm à direita, envolvendo a pleura mediastinal, sem massa pulmonar; placas pleurais calcificadas bilaterais. Não há linfonodomegalias. O próximo exame mais adequado é:

A) PET-CT de corpo inteiro

B) Biópsia pleural por toracoscopia

C) Terceira citologia do líquido pleural

D) Broncoscopia com lavado broncoalveolar

---

26 Homem de 28 anos, estudante de biologia, foi mordido na mão esquerda há 3 horas ao manusear uma serpente verde, de cerca de 1 metro, que capturou e trouxe ao PS; a mordida foi prolongada. O plantonista verifica que o animal não tem fosseta loreal, tem pupila redonda e cauda que afina gradualmente. Exame: edema doloroso no dorso da mão até o punho, equimose discreta local, sem bolhas, sem sangramento sistêmico, sem ptose. PA 124 × 78 mmHg, FC 88 bpm. Tempo de coagulação de 8 minutos (referência: até 10 minutos), repetido após 6 horas: 9 minutos. Plaquetas 230.000/mm³, CK 180 U/L. A conduta mais adequada é:

A) Soro antibotrópico, 4 ampolas

B) Analgesia, elevação e observação

C) Soro antibotrópico-laquético

D) Soro antibotrópico, 12 ampolas

---

27 Mulher de 68 anos tem há 3 meses diarreia aquosa, 6 a 8 evacuações ao dia, inclusive à noite, com urgência, sem sangue, sem febre e com perda de 3 kg. Começou, 2 meses antes da diarreia, um comprimido diário em jejum para pirose, que mantém; usa também sertralina há 6 anos e losartana. Exames: hemograma, PCR, TSH, eletrólitos e antitransglutaminase IgA (com IgA total normal) normais; coproparasitológico e toxina de Clostridioides difficile negativos; calprotectina fecal de 180 mcg/g. Colonoscopia com íleo e mucosa colônica macroscopicamente normais; as biópsias seriadas mostram banda de colágeno subepitelial de 18 micrômetros com aumento de linfócitos na lâmina própria. A conduta mais adequada é:

A) Budesonida oral e suspender o IBP

B) Mesalazina oral e suspender a sertralina

C) Prednisona oral e suspender o IBP

D) Loperamida e manter as medicações

---

28 Homem de 54 anos, com hipertensão e doença renal crônica (TFGe de 52 mL/min/1,73 m², albuminúria de 40 mg/g), em uso de losartana e anlodipino, traz ácido úrico de 9,8 mg/dL em duas dosagens. Nunca teve artrite, tofos ou cólica renal; ultrassom renal sem cálculos. Não usa diurético nem AAS. Bebe cerveja nos fins de semana e consome refrigerante adoçado diariamente. Pergunta se deve tratar o ácido úrico alto para proteger o rim. Além da orientação dietética, a conduta mais adequada quanto ao ácido úrico é:

A) Alopurinol 100 mg/dia com titulação

B) Febuxostate 40 mg/dia

C) Alopurinol com colchicina profilática

D) Não iniciar hipouricemiante

---

29 Mulher de 39 anos, com miomas uterinos e menorragia há 2 anos, queixa-se de cansaço. Hb 9,2 g/dL, VCM 69 fL, RDW 19%, leucócitos 7.800/mm³ com diferencial normal, plaquetas 712.000/mm³. Ferritina 5 ng/mL, saturação de transferrina 4%, PCR normal. Sem esplenomegalia, sem trombose prévia, sem eritromelalgia, sem cefaleia ou alterações visuais. Hemograma de 3 anos atrás, antes da menorragia, com plaquetas de 280.000/mm³. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Pesquisa de JAK2, CALR e MPL

B) Repor ferro e repetir hemograma

C) AAS e hidroxiureia

D) Biópsia de medula óssea

---

30 Homem de 61 anos, tabagista de 45 maços-ano, foi submetido há 3 semanas à extração de dois molares inferiores com abscesso periapical. Há 10 dias tem cefaleia progressiva e, há 2 dias, fraqueza na mão esquerda; teve uma crise focal motora hoje. Afebril, PA 142/84 mmHg. Hemiparesia esquerda grau 4, sem rigidez de nuca, fundo de olho sem papiledema. Leucócitos 11.800/mm³, PCR 3,2 mg/dL. TC de tórax: nódulo espiculado de 1,8 cm no lobo superior direito. RM de encéfalo: lesão frontoparietal direita de 3,2 cm com realce anelar de parede fina e regular, edema perilesional e restrição à difusão no centro da lesão. A conduta mais adequada é:

A) Aspiração estereotáxica e antibiótico

B) Dexametasona e radioterapia de crânio total

C) Punção lombar com cultura antes do antibiótico

D) Dexametasona e biópsia do nódulo pulmonar

---

31 Homem de 52 anos, com artrite reumatoide, vai iniciar tofacitinibe associado ao metotrexato. Teve varicela na infância e nunca recebeu vacina contra herpes-zóster. Para a prevenção do herpes-zóster, a conduta mais adequada é:

A) Valaciclovir profilático contínuo

B) Vacina atenuada 4 semanas antes

C) Nenhuma vacina, pela imunossupressão

D) Vacina recombinante adjuvada, duas doses

---

32 Homem de 57 anos, com diabetes tipo 2 há 8 anos em metformina e empagliflozina (HbA1c 7,2%), hipertensão e IMC de 32 kg/m², teve infarto sem supradesnivelamento de ST há 3 meses, tratado com angioplastia. Recebeu atorvastatina 80 mg/dia na alta, mas outro médico a suspendeu há 6 semanas ao ver transaminases elevadas e esteatose moderada na ultrassonografia, orientando aguardar a normalização. Antes da estatina, a ALT já era de 88 U/L. Consome uma dose de álcool por semana; HBsAg e anti-HCV negativos. Sem estigmas de hepatopatia, baço não palpável. Exames atuais: AST 58 U/L (VR até 40), ALT 96 U/L (VR até 41), bilirrubinas e albumina normais, plaquetas 245.000/mm³, LDL 148 mg/dL. Elastografia hepática transitória: 6,1 kPa. Em relação ao tratamento hipolipemiante, a conduta mais adequada é:

A) Reintroduzir atorvastatina 80 mg/dia

B) Ezetimiba isolada até normalizar a ALT

C) Aguardar a ALT normalizar, sem droga

D) Rosuvastatina 5 mg em dias alternados

---

33 Homem de 62 anos, engenheiro, é encaminhado por sopro encontrado em exame de rotina. Nega dispneia, angina ou síncope, mas conta que 'diminuiu o ritmo' das caminhadas no último ano, o que atribui à idade. Tem dislipidemia controlada e nenhuma outra comorbidade; risco cirúrgico STS de 1,2%. Exame: PA 132×80 mmHg, pulso carotídeo parvus et tardus, sopro sistólico ejetivo 4+/6+ em foco aórtico com frêmito, B2 única. Ecocardiograma: valva aórtica tricúspide calcificada, velocidade máxima de 4,4 m/s, gradiente médio de 48 mmHg, área valvar de 0,7 cm², fração de ejeção de 63%. Teste ergométrico: interrompido aos 4 minutos do protocolo de Bruce por dispneia desproporcional e tontura, com queda da PA sistólica de 150 para 128 mmHg. A conduta e a modalidade de tratamento são, respectivamente:

A) Intervenção agora / troca valvar cirúrgica

B) Intervenção agora / implante transcateter

C) Reavaliar em 6 meses / troca valvar cirúrgica

D) Reavaliar em 6 meses / implante transcateter

---

34 Homem de 24 anos tem retocolite ulcerativa extensa diagnosticada há 2 anos, em remissão clínica com mesalazina, com última colonoscopia há 10 meses mostrando mucosa cicatrizada. Na rotina, fosfatase alcalina de 380 U/L e GGT de 420 U/L persistentes há 6 meses, com bilirrubinas normais e assintomático. A colangiorressonância mostra estenoses curtas multifocais intercaladas com segmentos dilatados nas vias intra e extra-hepáticas, sem estenose dominante; antimitocôndria negativo e IgG4 sérica normal; elastografia de 7 kPa. Firmado o diagnóstico de colangite esclerosante primária, quanto à vigilância colonoscópica do câncer colorretal, a periodicidade e o início são, respectivamente:

A) A cada 3 anos / a partir de agora

B) A cada 3 anos / após 8 anos de colite

C) Anual / após 8 anos de colite

D) Anual / a partir de agora

---

35 Na mononucleose infecciosa pelo vírus Epstein-Barr em adulto jovem, o corticoide sistêmico está indicado, isoladamente, quando há:

A) Obstrução iminente de vias aéreas

B) Esplenomegalia acima de 4 cm

C) Odinofagia com exsudato extenso

D) Linfócitos atípicos acima de 20%

---

36 Homem de 70 anos, com DPOC (VEF1 35%) e insuficiência cardíaca, está intubado há 5 dias por exacerbação com acidose respiratória (pH inicial 7,18, PaCO2 92 mmHg). Hoje, sem sedação, está acordado e cooperativo, tem tosse eficaz e pouca secreção, sem vasopressor. Passou no teste de respiração espontânea de 30 minutos em pressão de suporte de 7 cmH2O: FR 24 irpm, SpO2 93% com FiO2 de 30%, sem desconforto. Gasometria ao fim do teste: pH 7,37, PaCO2 56 mmHg, HCO3 32 mEq/L. A equipe discute o que fazer agora. A conduta mais adequada é:

A) Extubar e iniciar VNI imediatamente

B) Extubar para cateter nasal de oxigênio

C) Manter intubado e repetir o teste amanhã

D) Indicar traqueostomia precoce

---

37 Mulher de 84 anos, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida (FE 30%) e doença renal crônica estágio 4, tem anemia por doença crônica e ferropenia, com Hb de 6,4 g/dL, dispneia aos pequenos esforços e tontura. Há 2 meses, em outra internação, teve sobrecarga circulatória associada à transfusão confirmada, após 2 concentrados de hemácias infundidos em 3 horas. Hoje está euvolêmica: PA 128/70 mmHg, FC 92 bpm, sem estertores, sem turgência jugular, SpO2 95% em ar ambiente. Peso de 52 kg. Para a transfusão de hoje, o número de unidades e o modo de infusão mais adequados são, respectivamente:

A) Uma unidade / infusão lenta com diurético

B) Duas unidades / infusão lenta com diurético

C) Uma unidade / infusão padrão em 2 horas

D) Duas unidades / infusão padrão em 2 horas

---

38 Homem de 46 anos, transplantado renal há 9 meses, usa tacrolimo, micofenolato e prednisona 5 mg/dia, com creatinina basal de 1,2 mg/dL. Há 10 dias iniciou claritromicina para sinusite. Conta que esqueceu algumas doses do micofenolato no mês passado. Hoje: creatinina 1,9 mg/dL, potássio 5,7 mEq/L, magnésio 1,3 mg/dL, glicose 210 mg/dL; tremor fino de mãos, PA 158/94 mmHg, diurese preservada, enxerto indolor, afebril. EAS sem hematúria e sem proteinúria significativa; ultrassom com Doppler do enxerto sem hidronefrose e com fluxo normal. O exame mais adequado neste momento é:

A) Biópsia do enxerto renal

B) PCR para poliomavírus BK no plasma

C) Nível sérico de vale do tacrolimo

D) Anticorpos anti-HLA específicos do doador

---

39 Homem de 66 anos, hipertenso e com fibrilação atrial sem anticoagulação, foi encontrado pela filha às 7 h caído ao lado da cama, 'sem responder'; ao lado havia um frasco de clonazepam com poucos comprimidos (o número exato é desconhecido). Fora visto bem às 23 h. No pronto-socorro, não fala e não move os membros; está de olhos abertos espontaneamente e, quando solicitado, olha para cima e fecha os olhos, repetindo o comando; não há movimentos horizontais dos olhos. Tetraplegia com Babinski bilateral. PA 178/96 mmHg, FC 104 bpm irregular, SpO2 95%. Glicemia 132 mg/dL, sódio 139 mEq/L. TC de crânio sem lesões agudas. O diagnóstico mais provável é:

A) Coma por intoxicação por benzodiazepínico

B) Síndrome do encarceramento por oclusão da basilar

C) Estado de mal epiléptico não convulsivo

D) Síndrome do encarceramento por mielinólise pontina

---

40 Homem de 46 anos, sem neoplasia conhecida, é internado no 1º dia de síndrome de sobreposição Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica atribuída ao sulfametoxazol-trimetoprima, com destacamento epidérmico de 18% da superfície corporal. FC 124 bpm, PA 108 × 64 mmHg. Exames da admissão: ureia 72 mg/dL (nitrogênio ureico 34 mg/dL), bicarbonato sérico 21 mEq/L, glicemia 238 mg/dL, creatinina 1,4 mg/dL. A pontuação do SCORTEN deste paciente é:

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

---

41 Primigesta de 27 anos, com 34 semanas, gestação gemelar, procura a maternidade com náuseas, vômitos e dor epigástrica há 5 dias, mal-estar, muita sede e urina abundante, e há 2 dias percebeu os olhos amarelados. Exame: sonolenta, mas orientada, ictérica 2+/4+, PA 142 × 92 mmHg, FC 104 bpm, dor leve em epigástrio, sem edema. Exames: glicemia 52 mg/dL, AST 420 U/L, ALT 380 U/L, bilirrubina total 6,8 mg/dL, INR 2,1, fibrinogênio 110 mg/dL, plaquetas 118.000/mm³, LDH 420 U/L, sem esquizócitos no esfregaço, leucócitos 19.500/mm³, creatinina 1,9 mg/dL, ácido úrico 9,8 mg/dL, proteinúria de fita 1+. Ultrassonografia: fígado discretamente hiperecogênico, sem hematoma subcapsular. O diagnóstico mais provável é:

A) Esteatose hepática aguda da gestação
B) Síndrome HELLP
C) Colestase intra-hepática da gestação
D) Hepatite viral aguda fulminante

---

42 Homem de 68 anos, hipertenso e diabético, sem cardiopatia estrutural, tem palpitações e cansaço há cerca de 10 dias, sem saber precisar o início. Há 8 meses teve episódio igual, revertido com cardioversão elétrica. Exame: PA 136×84 mmHg, FC 150 bpm, regular, sem congestão. ECG: ondas F em dente de serra, negativas em DII, DIII e aVF e positivas em V1, com condução 2:1. Ecocardiograma transtorácico: fração de ejeção de 55% e átrio esquerdo de 42 mm. Creatinina de 1,0 mg/dL. Recusa ecocardiograma transesofágico. Controlada a frequência, a estratégia para restaurar o ritmo e o tratamento de longo prazo do ritmo são, respectivamente:

A) Anticoagular 3 semanas antes / amiodarona contínua
B) Cardioversão imediata / amiodarona contínua
C) Cardioversão imediata / ablação do istmo cavotricuspídeo
D) Anticoagular 3 semanas antes / ablação do istmo cavotricuspídeo

---

43 Homem de 54 anos, transplantado renal há 5 meses (doador falecido), usa tacrolimo, micofenolato e prednisona 5 mg/dia, com creatinina estável de 1,3 mg/dL. Não tinha diabetes antes do transplante. No 3º mês pós-transplante teve anemia (hemoglobina de 7,8 g/dL), recebeu duas transfusões e iniciou eritropoetina; a hemoglobina atual é de 10,9 g/dL. Assintomático. Exames de rotina: glicemia de jejum de 112 e 118 mg/dL em duas ocasiões e HbA1c de 5,7%. Teste oral com 75 g de glicose, repetido com intervalo de 2 semanas: jejum de 114 e 117 mg/dL, e 2 horas de 236 e 224 mg/dL. Com esses dados, o diagnóstico é:

A) Diabetes pós-transplante

B) Glicemia de jejum alterada

C) Hiperglicemia transitória pelo corticoide

D) Tolerância diminuída à glicose

---

44 Mulher de 68 anos, hipertensa, tem há 2 dias dor em queimação e vesículas agrupadas sobre base eritematosa na fronte e no couro cabeludo à esquerda, sem cruzar a linha média, iniciadas após 3 dias de dor local. Há vesículas também na ponta e na asa do nariz à esquerda. Nega dor ocular, fotofobia ou baixa visual; o olho esquerdo não está hiperemiado à inspeção, e a acuidade visual é 20/25 em ambos. Sem déficit neurológico. Iniciou valaciclovir 1 g de 8/8 horas há 24 horas. O próximo exame mais adequado é:

A) PCR de vesícula para VZV

B) RM de crânio e órbitas

C) Punção lombar

D) Biomicroscopia com lâmpada de fenda

---

45 Mulher de 76 anos tem dispneia progressiva e tosse seca há 8 meses. Há pouco mais de um ano toma, toda noite, um comprimido para não ter mais infecção de urina, receitado pelo urologista. Hipertensa, usa também anlodipino. Nunca fumou; nega aves, mofo, artralgias e Raynaud. Crepitações finas em bases, sem baqueteamento. FAN, fator reumatoide e anti-CCP negativos. ALT 72 U/L. Espirometria: CVF 64% do previsto, VEF1/CVF 0,84; DLCO 51%. TC: opacidades reticulares e em vidro fosco basais e subpleurais, sem faveolamento. A geriatra anterior registrou provável fibrose pulmonar idiopática e sugeriu antifibrótico. A causa mais provável e a primeira conduta são, respectivamente:

A) Fibrose pulmonar idiopática / nintedanibe

B) Pneumonia em organização / prednisona oral

C) Pneumonite por nitrofurantoína / suspender

D) Pneumonite por nitrofurantoína / pulsoterapia

---

46 Na reposição de ferro oral para anemia ferropriva sem urgência, administrar a dose em dias alternados, em vez de duas ou três vezes ao dia, aumenta a fração de ferro absorvida porque:

A) A hepcidina sobe por cerca de 24 h após cada dose

B) O DMT1 duodenal é degradado com doses diárias

C) A ferroportina é induzida a cada 48 h

D) A transferrina satura e bloqueia a absorção

---

47 Mulher de 49 anos, sem história pessoal ou familiar de psoríase, iniciou azitromicina para sinusite há 2 dias. Há 12 horas surgiu eritema edematoso em face, pescoço, axilas e virilhas, salpicado por dezenas de pústulas puntiformes não foliculares, com ardor, e febre de 38,8 °C. Mucosas poupadas, sem bolhas e sem áreas de destacamento. PA 118 × 72 mmHg, FC 98 bpm. Exames: leucócitos 18.400/mm³ com 14.200 neutrófilos e 600 eosinófilos, PCR 9 mg/dL, creatinina e transaminases normais. Bacterioscopia do conteúdo de uma pústula: neutrófilos, sem bactérias. A azitromicina foi suspensa. O diagnóstico e a conduta são, respectivamente:

A) Psoríase pustulosa / prednisona oral

B) Pustulose exantemática / corticoide tópico

C) Pustulose exantemática / prednisona oral

D) Psoríase pustulosa / corticoide tópico

---

48 Mulher de 79 anos, com doença renal crônica (TFGe de 21 mL/min/1,73 m²) e osteoporose com fratura vertebral, recebeu há 12 dias a primeira dose da medicação antirreabsortiva subcutânea de aplicação semestral, escolhida porque o bisfosfonato estava contraindicado pela função renal. Hoje refere parestesias periorais e cãibras. Sinal de Chvostek presente. Exames: cálcio total de 6,9 mg/dL com albumina de 3,9 g/dL, fósforo 4,1 mg/dL, magnésio 2,0 mg/dL, PTH 390 pg/mL, 25-hidroxivitamina D de 16 ng/mL; o cálcio era de 9,0 mg/dL há 1 mês, com os demais exames semelhantes. QTc de 500 ms. A causa principal da hipocalcemia é:

A) Ação do denosumabe

B) Deficiência de vitamina D

C) Hipoparatireoidismo

D) Hiperfosfatemia da DRC

---

49 Homem de 58 anos, com adenocarcinoma de cólon sigmoide diagnosticado por colonoscopia, tem na TC múltiplas metástases hepáticas bilobares, consideradas irressecáveis pela equipe de cirurgia hepática, sem doença extra-hepática. ECOG 1, função hepática e renal normais, CEA de 84 ng/mL. A oncologista considera iniciar quimioterapia com FOLFOX associada a anticorpo monoclonal anti-EGFR, pela localização à esquerda do tumor primário. A biópsia da lesão primária só tem o diagnóstico histológico. Antes de definir o esquema, o próximo exame mais adequado é:

A) Imuno-histoquímica para expressão de EGFR

B) PET-CT com FDG de corpo inteiro

C) CEA e CA 19-9 seriados por 4 semanas

D) Pesquisa de RAS, BRAF e reparo de DNA no tumor

---

50 Em paciente com tremor essencial que limita a escrita e o uso de talheres, e que tem asma persistente em uso de budesonida-formoterol, o tratamento oral de primeira escolha é:

A) Propranolol

B) Clonazepam

C) Primidona

D) Levodopa

FOLHA DE RESPOSTAS

Simulado 10

Nome: _____ Data: ___/___/_____ Início: ___h___ Fim: ___h___

1 (A) (B) (C) (D)	2 (A) (B) (C) (D)	3 (A) (B) (C) (D)	4 (A) (B) (C) (D)
5 (A) (B) (C) (D)	6 (A) (B) (C) (D)	7 (A) (B) (C) (D)	8 (A) (B) (C) (D)
9 (A) (B) (C) (D)	10 (A) (B) (C) (D)	11 (A) (B) (C) (D)	12 (A) (B) (C) (D)
13 (A) (B) (C) (D)	14 (A) (B) (C) (D)	15 (A) (B) (C) (D)	16 (A) (B) (C) (D)
17 (A) (B) (C) (D)	18 (A) (B) (C) (D)	19 (A) (B) (C) (D)	20 (A) (B) (C) (D)
21 (A) (B) (C) (D)	22 (A) (B) (C) (D)	23 (A) (B) (C) (D)	24 (A) (B) (C) (D)
25 (A) (B) (C) (D)	26 (A) (B) (C) (D)	27 (A) (B) (C) (D)	28 (A) (B) (C) (D)
29 (A) (B) (C) (D)	30 (A) (B) (C) (D)	31 (A) (B) (C) (D)	32 (A) (B) (C) (D)
33 (A) (B) (C) (D)	34 (A) (B) (C) (D)	35 (A) (B) (C) (D)	36 (A) (B) (C) (D)
37 (A) (B) (C) (D)	38 (A) (B) (C) (D)	39 (A) (B) (C) (D)	40 (A) (B) (C) (D)
41 (A) (B) (C) (D)	42 (A) (B) (C) (D)	43 (A) (B) (C) (D)	44 (A) (B) (C) (D)
45 (A) (B) (C) (D)	46 (A) (B) (C) (D)	47 (A) (B) (C) (D)	48 (A) (B) (C) (D)
49 (A) (B) (C) (D)	50 (A) (B) (C) (D)		